EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	70624
SERVICIO	:	UTI HSC			
FECHA	:	2023-09-11 16:32:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN ANTONIO SAN MARTIN MENDEZ			RUN	: 5.216.467-2
F.Nac	: 15-12-1945	Edad	: 77 AÑOS, 8 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-09-04	Fecha Egreso	: 2023-09-11 16:32:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R11.X-NEUSEA Y VOMITO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria global:
- EPOC exacerbado
2. ICC descompensada (FEVI reducida 30%)
3. Lesión renal aguda KDIGO 3/ ERC etapa 3a(crea basal 1.5-1.7)
4. FA permanente en TACO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J44.1-ENF. PULM. OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUD.,NO ESP (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I50.0-INSUFICIENCIA CARD?ACA CONGESTIVA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. N17-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. N18.3-ENFERMEDAD RENAL CRONICA,ESTADIO 3 (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. I48-FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de EPOC, ICC cFEr, ERC etapa 3a, es hospitalizado en Medicina Agudo por exacerbación de EPOC insuficiencia respiratoria hipercápnica asociado a insuficiencia cardiaca descompensada. Fue anejado con broncodilatación y diuréticos con respuesta parcial. El día 06/09 destaca control gasometrico con acidosis e hipercapnia (pH 7.20 pCo2 72), por lo que se instala VMNI con respuesta tórpida, mejorando Ph a 7.24 pero mantiene retención de CO2. Por necesidad de mantener apoyo de VMNI se decide ingreso a UTI.
Evolución en UTI:
- Hemodinamia: se mantiene bajo monitorización continua, hemodinamia autosostenida, en FA al monitor. Con terapia antihipertensiva, depletiva, anticoagulación con HBPM por FA permanente. Sin mayor conflicto durante estadia en UTI.
- Ventilatorio: al ingreso se optimiza broncodilatación, inicio corticoides y se ajustan parámetros VMNI modo ST, con buena respuesta, logrando mejoría de pH y de hipercapnia.
- Infecto: se mantiene afebril, parámetros inflamatorios bajos, bajo cobertura empírica con ceftriaxona por exacerbación de EPOC, completando 5 días. CSB negativo, panel viral negativo.
- Renal: ingresa con deterioro función renal respecto a su basal, actualmente en vías de normalización. Función renal en recuperación, con diuresis conservada. crea 1.6 BUN 43
En condición para continuar tratamiento kinésico por HODOM.

PLAN DE MANEJO:

HODOM para KNT respiratoria
Control Poli TACO

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo, movilizar por Kine según tolerancia
2. Regimen liviano hiposódico, restricción hídrica 1000 cc al dia maximo en total
3. Bromuro de Ipratopio 4 puff cada 6 horas cAC
4. Fluticasona/Salmeterol (250/25) 2puff cada 12 horas cAC
5. Salbutamol: 2 puff cada 6 horas.
6. Bisoprolol 2,5mg por dia vo
7. Omeprazol 20 mg al dia vo
8. Furosemida 40mg al dia vo
9. Acenocumarol 4 mg 1 comprimido hoy, resto guiarse por Carnet de Poli TACO
10. HODOM: KNT respiratoria, vigilar INR

EXÁMENES Y RESULTADOS
11/09/23: crea 1,6 BUN 43 PCR <5 ELP 141/4.0/100
Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Ana Sepúlveda Venegas
MEDICO TRATANTE
13383078-2

JEFE SERVICIO